Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60999
Título: Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da Cidade de São Paulo - Avança Saúde II
Título Abreviado: Avança Saúde II
Mutuário: Município de São Paulo - SP
Setor: Desenvolvimento Social
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria Municipal da Saúde - Prefeitura do Município de São Paulo	SP

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 410.600.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	Dólar	205.300.000,00	1,000	205.300.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	205.300.000,00	1,000	205.300.000,00
Total					410.600.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL

O objetivo do Programa é contribuir para a melhorar as condições de saúde da população do Município de São Paulo, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A.Adequar à legislação e ampliar a infraestrutura física da Rede Hospitalar Municipal.
B.Ampliar e modernizar o atendimento de hospitais municipal.
C.Certificar a qualidade de 24 hospitais e 6 laboratórios municipais.
D.Melhorar a eficiência e segurança na logística dos medicamentos e insumos intra-hospitalar
E.Capacitar profissionais da SMS para operacionalização do sistema de suprimentos intra-hospitalar e implantação dos processos de qualidade

O alinhamento dos objetivos resultados e indicadores encontra-se no anexo 8.2

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de cirurgia eletivas por mês	Numerador: Contagem absoluta de AIH, com procedimento realizado do grupo 04 .xx.xx.xxx-xx, excetuando os procedimentos obstétricos (04.11.xx. xxx-xx) Denominador: número de meses considerados * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa	cirurgias/mês	789,50	950,00
Tempo médio de Internação	Numerador: soma de Dias de Perm de todas as AIH do período considerado Denominador: contagem de AIH no período considerado (todas as AIH) * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa	dias/AIH	6,18	5,00
Percentual de hospitais e laboratórios com certificação hospitalar	Numerador: Número de hospitais e laboratórios certificados no âmbito do programa financiado com recursos de empréstimo Denominador: Número de hospitais e laboratórios existentes	percentual	0,00	100,00
Taxa de Mortalidade Institucional	Numerador: contagem de AIH com motivo de cobrança óbito Denominador: contagem de AIH (todas as formas de saída no período considerado) * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa	percentual	5,50	4,00

Número cirurgias por sala cirúrgica por dia	Numerador: quantidade total de saidas de AIH com procedimento cirurgico (excetuando obstetrícia 04.11.xx. xxx-xx) realizadas no mês Denominador: quantidade de salas cirurgicas-dia no mês (salas cirúrgicas CNES) * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa ** Salas consideradas: Sala de Cirurgia, Sala Cirurgia Ambulatorial	cirurgias/sala-dia	2,00	2,50
Número de saídas por mês	Numerador: contagem de saidas de AIH (todos os motivos) Denominador: número de meses considerados * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa	Saídas / mês	8.361,00	9.200,00
Número de conformidades de infraestrutura hospitalar	Numerador: Número de hospitais com infraestrutura conforme Denominador: Número de hospitais atendidos por reforma pelo programa (13 hospitais)	percentual	0,00	100,00
Profissionais capacitados	Número de profissionais capacitados no Programa Avança Saúde II	número de profissionais	0,00	1.300,00
Modelagem de PPP Hospitalar entregues	Número de modelagem de PPP Hospitalar entregues	Relatorios	0,00	3,00
satisfação dos usuários aos serviços prestados nos hospitais.	Numerador: soma das notas atribuidas pelos usuários de 0-10 Denominador: número de respostas * Hospitais considerados: 13 hospitais do Programa	nota	0,00	7,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	**-**	**0,00**	**299.280.000,00**
001.000.001 - 1.1 Requalificação dos Hospitais	**Número de hospitais**	10,00	214.000.000,00
001.000.002 - 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais	**Número de hospitais**	3,00	60.000.000,00
001.000.003 - 1.3 Hospitais equipados e mobiliados	**Número de hospitais**	10,00	19.280.000,00
001.000.004 - 1.4 Apoio técnico à realização das obras	**Relatórios**	48,00	6.000.000,00

002 - COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO	**-**	**0,00**	**102.820.000,00**
002.000.001 - 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar	**No.hospitais modelados**	3,00	3.000.000,00
002.000.002 - 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar	**No Hospitais sistema impl**	13,00	98.220.000,00
002.000.003 - 2.3 Certificação da Qualidade	**Equip. saúde certificados**	30,00	800.000,00
002.000.004 - 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	**Equip. saúde proc. aprim.**	30,00	600.000,00
002.000.005 - 2.5 Capacitação	**Profissionais capacitados**	300,00	200.000,00
003 - COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**8.500.000,00**
003.000.001 - 3.1 Apoio ao Gerenciamento	**Relatórios**	48,00	6.000.000,00
003.000.002 - 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa	**Relatórios**	48,00	1.600.000,00
003.000.003 - 3.3 Consultoria de Comunicação	**Relatórios**	48,00	300.000,00
003.000.004 - 3.4 Avaliação do Programa	**Relatórios**	8,00	600.000,00
Total			**410.600.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**214.000.000,00**	**52,12**
P- 1.1 Requalificação dos Hospitais	Número de hospitais	10,00	214.000.000,00	52,12
Bens	**-**	**-**	**79.280.000,00**	**19,31**
P- 1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais	Número de hospitais	3,00	60.000.000,00	14,61
P- 1.3 Hospitais equipados e mobiliados	Número de hospitais	10,00	19.280.000,00	4,70
Consultoria	**-**	**-**	**18.100.000,00**	**4,41**
P- 1.4 Apoio técnico à realização das obras	Relatórios	48,00	6.000.000,00	1,46
P- 2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar	No.hospitais modelados	3,00	3.000.000,00	0,73
P- 2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	Equip. saúde proc. aprim.	30,00	600.000,00	0,15
P- 3.1 Apoio ao Gerenciamento	Relatórios	48,00	6.000.000,00	1,46
P- 3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa	Relatórios	48,00	1.600.000,00	0,39
P- 3.3 Consultoria de Comunicação	Relatórios	48,00	300.000,00	0,07
P- 3.4 Avaliação do Programa	Relatórios	8,00	600.000,00	0,15
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**99.020.000,00**	**24,12**
P- 2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar	No Hospitais sistema impl	13,00	98.220.000,00	23,92
P- 2.3 Certificação da Qualidade	Equip. saúde certificados	30,00	800.000,00	0,19
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**200.000,00**	**0,05**
P- 2.5 Capacitação	Profissionais capacitados	300,00	200.000,00	0,05
Total Geral	**-**	**-**	**410.600.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 BID	Ano 1 CF	Ano 2 BID	Ano 2 CF	Ano 3 BID	Ano 3 CF	Ano 4 BID	Ano 4 CF	Ano 5 BID	Ano 5 CF	Total BID	Total CF
COMPONENTE 1: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	**299.280.000,00**	**20.500.000,00**	**20.000.000,00**	**31.500.000,00**	**29.575.000,00**	**37.000.000,00**	**39.510.000,00**	**31.500.000,00**	**39.485.000,00**	**21.000.000,00**	**29.210.000,00**	**141.500.000,00**	**157.780.000,00**
1.1 Requalificação dos Hospitais	214.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	27.295.000,00	35.000.000,00	31.205.000,00	30.000.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	135.500.000,00	78.500.000,00
1.2 Parceria Público Privada para requalificação dos Hospitais	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.3 Hospitais equipados e mobiliados	19.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	8.305.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	6.210.000,00	0,00	19.280.000,00
1.4 Apoio técnico à realização das obras	6.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
COMPONENTE 2: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO	**102.820.000,00**	**2.220.000,00**	**0,00**	**11.600.000,00**	**10.100.000,00**	**16.695.000,00**	**10.195.000,00**	**15.770.000,00**	**10.270.000,00**	**10.435.000,00**	**15.535.000,00**	**56.720.000,00**	**46.100.000,00**
2.1 Modelagem da PPP na Atenção Hospitalar	3.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.2 Sistema de Logística Intra-Hospitalar	98.220.000,00	1.720.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.500.000,00	10.000.000,00	15.500.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	15.300.000,00	52.920.000,00	45.300.000,00
2.3 Certificação da Qualidade	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4 Apoio à certificação de qualidade hospitalar	600.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00
2.5 Capacitação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**8.500.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**1.565.000,00**	**325.000,00**	**1.695.000,00**	**295.000,00**	**1.645.000,00**	**245.000,00**	**1.615.000,00**	**555.000,00**	**7.080.000,00**	**1.420.000,00**
3.1 Apoio ao Gerenciamento	6.000.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.000,00	170.000,00	5.830.000,00	170.000,00
3.2 Consultoria para Coordenação Setorial do Programa	1.600.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	260.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	800.000,00	800.000,00
3.3 Consultoria de Comunicação	300.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
3.4 Avaliação do Programa	600.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00	130.000,00	300.000,00	300.000,00
Total	410.600.000,00	23.280.000,00	20.000.000,00	44.665.000,00	40.000.000,00	55.390.000,00	50.000.000,00	48.915.000,00	50.000.000,00	33.050.000,00	45.300.000,00	205.300.000,00	205.300.000,00

Parecer Técnico: Heder Carlos de Oliveira

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

No marco de referência, o mutuário destaca o processo de transição demográfica no Município de São Paulo (MSP) e descreve a dinâmica do envelhecimento populacional e seus impactos sobre a definição da agenda de políticas públicas no setor de saúde. Essa agenda está associada à ampliação da demanda por ações de cuidado relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), agravadas por comorbidades. O mutuário apresenta uma justificativa clara, isto é, descreve a situação-problema do Município, no que tange às estatísticas de prevalência das DCNT, e aos indicadores de internações hospitalares ocorridas em estabelecimentos de saúde da Rede SUS sob gestão municipal e estadual (SES), em 2021, com base no diagnóstico principal de doenças classificadas no CID 10 e relacionadas às DCNT. Além disso, é descrito o impacto da COVID19 no sistema de saúde, que ampliou significativamente as internações relacionadas ao diagnóstico "algumas doenças infecciosas e parasitárias" e a predominância de internações relacionadas às DCNT.

Conforme apresentado na carta-consulta, os problemas apontados pelo mutuário dizem respeito ao perfil epidemiológico relacionado às DCNT , os agravantes no sistema de saúde no que diz respeito à alta densidade populacional, enormes desigualdades intrarregionais e o envelhecimento populacional crescente, bem como, as características da rede física de saúde para atenção primária, pronto atendimento, unidades básicas de saúde, redes hospitalares e os desafios que permeiam esse sistema.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÕES PROPOSTAS - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

É possível verificar a congruência entre as soluções propostas e a problemática identificada, orientadas prioritariamente ao esforço em reduzir as principais inadequações da infraestrutura do sistema de saúde do Município de São Paulo, ampliando a capacidade de atendimento à população que mais necessita do serviço de saúde pública. As soluções propostas buscam, portanto, o enfrentamento das dificuldades de atendimento ao público, da qualificação tecno-assistencial dos profissionais de saúde e da precariedade da infraestrutura do sistema de saúde público no MSP.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O mutuário demonstra a aderência do Programa a projetos estratégicos do MSP, como por exemplo, ao Plano Municipal de Saúde 2022-2025 e à reestruturação da Secretaria de Saúde, iniciada com o Decreto nº 59.685, de 13 de agosto de 2020. Também foi demonstrado o alinhamento do Programa com o PPA 2022-2025. Segundo o mutuário, a contrapartida financeira ao Programa será proveniente de receitas tributárias do Município, e já há recurso disponível para contratação de obras de reforma para 6 hospitais, que serão realizadas integralmente com recursos de contrapartida.

PROJETO/OBJETIVO GERAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do projeto está alinhado com as soluções propostas e resultados esperados, uma vez que busca contribuir para a melhora das condições de saúde da população do Município de São Paulo, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal. Uma vez que os objetivos específicos estão interligados com o objetivo geral e, este último está alinhando com as soluções propostas e com os resultados esperados, é possível verificar o alinhamento dos objetivos específicos com as soluções e resultados esperados do projeto, principalmente, relacionados à ampliação dos atendimentos, modernização da infraestrutura hospitalar e capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para operacionalização do sistema de suprimentos intra-hospitalar e implantação dos processos de qualidade.

PROJETO/INDICADORES:

Cada indicador apresenta uma descrição específica em relação ao respectivo resultado esperado. Por exemplo, o indicador "Percentuais de hospitais e laboratórios com certificação hospitalar" está conectado com o resultado esperado "Com relação à certificação de qualidade, espera-se melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais de saúde, tornando os processos de trabalho mais eficientes com melhor integração entre setores." Foram definidos os indicadores e as metas, com o estabelecimento de prazos e dados disponíveis dentro do tempo do Programa, conforme descrito nos anexos 8. 1 e 8.2. Ainda que os indicadores estejam objetivos e passíveis de cálculo, apresentam limitações metodológicas de suas propriedades, tais como: validade (grau de proximidade entre conceito e a medida); confiabilidade (qualidade do levantamento dos dados) e factibilidade (é possível atingi-lo?). Tais informações agregariam maior valor à avaliação do quesito na carta-consulta.

PROJETO/COMPONENTES:

Os componentes do projeto proposto estão definidos de forma alinhada à proposta apresentada, levando em consideração o diagnóstico e soluções esperadas. Foram definidos três componentes relacionados à: C1 "Requalificação da infraestrutura hospitalar", C2 "Aprimoramento dos processos e inovação", C3 "Administração e avaliação do programa". Todos estes componentes possuem seus subcomponentes e produtos associados voltados ao diagnóstico e soluções do projeto. Além disso, a distribuição dos recursos parece coerente com os componentes apresentados e suas complexidades. O componente C1 apresenta o maior valor dos recursos financiados (US$ 299,28 milhões de dólares), no qual está associado aos produtos de Requalificação dos Hospitais, Estratégias de Parcerias Público Privadas, Readequação de equipamentos e mobiliário dos hospitais e, Apoio técnico à realização das obras.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Segundo o mutuário, as questões propostas na carta-consulta possuem antecedentes, com políticas públicas implementadas no MSP. Em junho de 2019, foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o Município de São Paulo e o BID para o Programa Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - Avança Saúde SP, com objetivo de melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde , tendo como foco a atenção primária e a rede de urgência e emergência, bem como o fortalecimento da gestão da informação com incentivo à inovação e uso de novas tecnologias em saúde. Além disso, o proponente descreveu ações já executadas e passos iniciais adotados para cumprimento de outras ações que compõem o Programa. Dentre as etapas realizadas, foram destacadas ações que visam dar transparência e levar conhecimento para a população sobre as obras hospitalares em andamento, por meio do Sistema ObraGov, além da implantação do sistema de suprimentos que possibilitará à SMS aprimorar o controle da logística de medicamentos e insumos ao integrar informações sobre o estoque central e com os estoques locais (aproximadamente mil unidades de saúde).

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

A abrangência geográfica do projeto é municipal - Município de São Paulo - SP.

PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

O proponente apresenta a justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções de financiamento interno, bem como as propostas e condições de financiamento externo, contendo prazo de desembolsos, taxa de juros e carência. O período de desembolso previsto e a carência são, ambos, de 5 (cinco) anos. Além disso, apresenta a justificativa da escolha do financiamento externo junto ao BID pautada na opção factível devido ao reconhecimento da expertise do Banco em financiar grandes projetos com finalidades similares, tanto no Brasil quanto nos demais países membros. O BID é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe, e para a integração regional, e, na área de políticas integradas de saúde, o banco financia, atualmente, cerca de 50 projetos em toda América Latina e Caribe.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Foi informada e qualificada de forma clara a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do projeto. Segundo consta na carta-consulta, o projeto terá como beneficiários das ações propostas todos os cidadãos do Município de São Paulo, ou seja, mais de 12 milhões de habitantes. Além da capital paulista, os munícipios paulistanos que compõem a Região Metropolitana de São Paulo também usufruirão dos impactos do Programa proposto.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O proponente indicou os valores de financiamento e contrapartida, bem como a moeda (dólar estadunidense) e sua conversão para o câmbio. O projeto apresenta o valor total previsto de US$ 410.600.000,00 sendo: US$ 205.300.000,00 em contrapartida financeira do Município, e US$ 205.300.000,00 em financiamento junto ao BID.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ARRANJO OPERACIONAL:

A Matriz de Responsabilidade foi apresentada com distribuição de competências entre as entregas previstas no Programa, com detalhamento apresentado no documento anexo nº 6. No entanto, a Matriz foi descrita de modo simplificado, com limitações em seu conteúdo relacionadas às principais atividades, órgãos envolvidos e execução. Foram apresentadas informações suficientes e objetivas em relação aos componentes e entregas do projeto, embora não tenham sido apresentadas informações detalhadas sobre a equipe técnica responsável pelo Programa.

EXECUÇÃO/ÓRGÃO EXECUTOR:

O órgão executor será a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que possui experiência em projetos com cooperação internacional, com destaque para a experiência prévia na execução do recente Programa Avança Saúde I.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

Foi apresentado o cronograma de desembolsos em 5 anos, com distribuição aparentemente adequada e compatível dos recursos, com base na Execução/Cronograma e a complexidade do projeto.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Como avaliado no item anterior, o mutuário apresentou o cronograma de desembolsos em 5 anos, com distribuição aparentemente adequada dos recursos e compatível com a complexidade do projeto proposto.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

As informações foram apresentadas de forma incompleta e imprecisa, abrindo margem para possíveis dificuldades, sem ações mitigatórias descritas. Não foram identificados os riscos legais relacionados à autorização do presente financiamento, portanto, não se descrevem ações que poderiam mitigar tais riscos, como, por exemplo, o acompanhamento e monitoramento do pleito ora em análise e alinhamento das atividades que competem ao próprio Município.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

Referente aos riscos de contratações, o mutuário descreveu os desafios que podem incorrer a partir das Eleições Municipais de 2024, resultando em possível revisão das ações e alteração das prioridades de programas como este. Como ações mitigatórias, foram descritos atos que serão direcionados para que o contrato de empréstimo esteja firmado, e o início das ações do Programa possam ocorrer antes das Eleições Municipais de 2024.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O mutuário informou que, por se tratar de reformas em terrenos de posse da Prefeitura, para a realização deste Programa não estão previstas desapropriações ou indenizações.

RISCOS/IMPACTO AMBIENTAL

Os riscos relacionados a impactos ambientais decorrentes da implementação do projeto foram pouco explorados. Por exemplo, os impactos ambientais em relação ao aumento de atendimento e descartes de materiais de risco biológico e possíveis ações mitigatórias não foram exploradas.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Não foram previstos riscos de impacto social decorrentes do projeto, bem como possíveis ações mitigadoras. Por exemplo, poderiam ser avaliados os riscos do aumento de custos para manutenção dos hospitais e unidades de atendimentos, que causariam possíveis impactos sociais.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O mutuário informou que para a realização deste Programa, não serão necessários reassentamentos, por se tratar de obras de reforma em terrenos da Prefeitura.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO - CC60999

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,432/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,692/1,800

- Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700

As informações apresentadas estão adequadas, passíveis de compreensão e detalhadas, tendo sido identificados os problemas e suas respectivas propostas de soluções. É importante salientar que os problemas identificados estão relacionados às questões do perfil epidemiológico relacionado às DCNT, os agravantes no sistema de saúde no que diz respeito à alta densidade populacional, enormes desigualdades intrarregionais e o envelhecimento populacional crescente, bem como as características da rede física de saúde para atenção primária, pronto atendimento, unidades básicas de saúde, redes hospitalares e os desafios que permeiam esse sistema.

É possível verificar a congruência entre as ações e soluções para tratar as problemáticas identificadas, orientadas prioritariamente ao esforço em reduzir as inadequações da infraestrutura do sistema de saúde do Município de São Paulo e a capacidade de atendimento à população que mais necessita do serviço de saúde pública. Conforme destacado na descrição do diagnóstico, o problema identificado está relacionado à alta concentração populacional, infraestrutura pública de saúde e sua capacidade de atendimento e a necessidade de melhorar o desempenho dos processos. As soluções propostas buscam, de alguma forma, o enfrentamento das dificuldades de atendimento ao público, da qualificação tecno-assistencial dos profissionais de saúde e da precariedade da infraestrutura do sistema de saúde público no MSP.

- Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

O objetivo geral está alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados, uma vez que o Programa busca contribuir para a melhora das condições de saúde da população do Município, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal. Uma vez que os objetivos específicos estão interligados com o objetivo geral e, este último está alinhando com as soluções propostas e com os resultados esperados, é possível verificar o alinhamento dos objetivos específicos com as soluções e resultados esperados do projeto. Em uma perspectiva mais ampla , os objetivos, geral e específicos, são definidos de forma clara, mas com algumas informações que carecem de detalhamento nos componentes. Vale salientar que os componentes do programa estão diretamente alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

- Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

Cada indicador apresenta uma descrição específica em relação ao respectivo resultado esperado. Por exemplo, o indicador "Percentuais de hospitais e laboratórios com certificação hospitalar" está conectado com o resultado esperado "Com relação a certificação de qualidade espera -se melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais de saúde tornando os processos de trabalho mais eficientes com melhor integração entre setores." Foram definidos os indicadores e as metas, com o estabelecimento dos prazos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto, conforme descrito nos anexos 8.1 e 8.2. Ainda que os indicadores sejam objetivos e passíveis de cálculo, apresentam limitações metodológicas de suas propriedades , tais como: validade (grau de proximidade entre conceito e a medida); confiabilidade (qualidade do levantamento dos dados) e; factibilidade (é possível atingi-lo?).

- Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

Prazo aparentemente compatível, com base na Execução/Cronograma e na complexidade do projeto. Cronograma de desembolsos em 5 anos , com distribuição adequada dos recursos, diante da complexidade do projeto. De forma mais detalhada, é informado que os desembolsos estão concentrados nas atividades descritas nos 3o e 4o anos. No primeiro ano, trata-se de desembolsos para Modelagem das Parcerias Público-Privadas, Análise de Certificação de Qualidade e Hospitalar, e Consultorias dentro de outros Produtos relacionados à fase inicial do Programa. No segundo ano, iniciam-se os Produtos de Readequação hospitalar, mas o grande volume se dará nos 3o e 4o anos, com previsão desembolsos de 26% e 24 %, respectivamente. O último ano está mais voltado para as ações das Parcerias Público-Privadas, Sistemas de Logística Intra-hospitalar e Mobiliário e adequação hospitalar.

- Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

O proponente apresenta a justificativa pela escolha do financiamento externo em detrimento às opções de financiamento interno, bem como as propostas e condições de financiamento externo. Além disso, foram apresentadas informações sobre condições, prazo de desembolsos, taxa de juros e carência. O período de desembolsos previsto no projeto e carência são, ambos, de 5 (cinco) anos. Além disso, o proponente escolheu o financiamento externo junto ao BID devido ao reconhecimento da expertise do Banco em financiar grandes projetos com finalidades similares, tanto no Brasil quanto nos demais países membros.

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,746/1,000

- Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Matriz de Responsabilidade foi apresentada com distribuição de competências entre as entregas previstas no Programa, com detalhamento descrito no anexo 6. No entanto, foi descrita de modo simplificado, com limitações ao conteúdo relacionado às principais atividades, órgãos envolvidos e execução. Foram apresentadas informações suficientes e objetivas em relação aos componentes e entregas do projeto. Não foi apresentada informação detalhada da equipe técnica responsável. O órgão executor será a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que possui experiência em projetos com cooperação internacional, com destaque para a experiência prévia na execução de projetos com organismos internacionais, como foi o caso recente do Avança Saúde I.

- Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,088/0,300

Não foram apresentadas medidas em relação à garantia de sustentabilidade financeira e de manutenção das ações do programa proposto. As informações de operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto foram insuficientes, não sendo disponibilizadas informações sobre a previsão de instrumento e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações. Foi disponibilizado no anexo 11, os valores do incremento de custeio e manutenção referente as ampliações dos 13 hospitais atendidos pelo Programa. Também, foi comparado com as despesas da área Hospitalar (PPA 22-25 - anexo 10).

- Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O mutuário demonstra a aderência do Programa a projetos estratégicos do Município, como por exemplo, o Plano Municipal de Saúde 2022-2025, e a reestruturação da Secretaria de Saúde, iniciada com o Decreto nº 59.685, de 13 de agosto de 2020. Também foi demonstrado o alinhamento do Programa com o PPA 2022-2025, bem como com os objetivos e metas da Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 0,994/1,200

- Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

Segundo o mutuário, as questões propostas na carta-consulta possuem antecedentes, com políticas públicas implementadas no MSP. Em junho de 2019, foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o Município e o BID para o Programa Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - o Avança Saúde SP I, com objetivo de melhorar acesso e qualidade dos serviços, tendo como foco a atenção primária e a rede de urgência e emergência, bem como o fortalecimento da gestão da informação com incentivo à inovação e uso de novas tecnologias em saúde. Para dar continuidade aos avanços e ganhos do Avança Saúde I, propõe-se, portanto, o Avança Saúde II, com os novos focos descritos. Além disso, o proponente descreveu ações já executadas e passos iniciais adotados para cumprimento de outras ações que compõem o novo Programa. Por exemplo, foram destacadas ações que visam dar transparência e levar conhecimento para a população sobre as obras em andamento, - Sistema ObraGov -, com os resultados obtidos a partir do Programa Avança Saúde I, e a implantação do sistema de suprimentos, que possibilitará que a SMS aprimore o controle da logística de medicamentos e insumos, ao integrar informações sobre o estoque central e estoques locais (aproximadamente mil unidades de saúde).

- Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,258/0,400

Quanto aos riscos legais, as informações foram apresentadas de forma imprecisa, pois não foram identificados os riscos relacionados à autorização do financiamento e as ações que poderão mitigar tais riscos, como, por exemplo, o acompanhamento e monitoramento do pleito e alinhamento das atividades que competem ao próprio Município.

Referente aos riscos de contratações, o mutuário descreveu as dificuldades que podem incorrer a partir das Eleições Municipais de 2024, que poderão resultar em revisão das ações e alteração das prioridades do Programas. Como ações mitigatórias, foram descritas as linhas de ação para que o contrato de empréstimo esteja firmado e o início das ações do Programa ocorram antes das Eleições Municipais previstas para 2024.

Os riscos relacionados a impactos ambientais decorrentes da implementação do projeto foram pouco explorados. Por exemplo, impactos ambientais em relação ao aumento de atendimento e descartes de materiais de risco biológico e possíveis ações mitigatórias não foram debatidas. Também, não foram discutidos riscos de impacto social, como por exemplo, risco de aumento de custos para manutenção dos hospitais e unidades de atendimentos, de forma a mitigar seus possíveis impactos sociais. Por fim, o mutuário informou que, para a realização deste Programa, não serão necessários reassentamentos ou desapropriações, por se tratar de obras de reforma em terrenos da Prefeitura.

- Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400

O mutuário informa sua experiência na execução de operações de crédito externo. Foi destacado o Programa Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - Avança Saúde SP, com objetivo de melhorar acesso e qualidade dos serviços, tendo como foco a atenção primária e a rede de urgência e emergência, bem como o fortalecimento da gestão da informação com incentivo à inovação e uso de novas tecnologias em saúde.

O cálculo, desse quesito foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. As informações foram extraídas do sistema Sigs: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. A nota média do Município está em 78,59/100,0 com avaliação no período correspondente.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,67/2,000

Pontuação atribuída pelo fato do programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O Programa traz a proposta de que, quanto à eficiência energética, serão instalados painéis fotovoltaicos, promovendo geração e uso de energia de fontes renováveis.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para a populações de baixa renda e vulneráveis

O Programa visa a melhoria das condições de saúde da população do Município de São Paulo, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal. Populações de baixa renda e vulneráveis são as mais carentes de atendimento de Saúde, portanto, as intervenções propostas, ao melhorarem/ampliarem a oferta dos serviços hospitalares, irão atender majoritariamente este Público, que utiliza o sistema público municipal.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã

O Programa tem como objetivo específico a certificação de qualidade dos serviços públicos de saúde prestados, que implicará em melhoria da prestação/processos dos serviços ofertados nos Hospitais, garantindo maior segurança para pacientes e profissionais de saúde, tornando os processos de trabalho mais eficientes com melhor integração entre setores.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

As ações do Programa visam a melhoria das condições de saúde da população por meio do aprimoramento do atendimento hospitalar municipal.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Estão previstos Produtos para a realização de Parceria Público-Privada, com destaque para as possibilidades de soluções inovadoras pelo ator privado, a otimização dos serviços com a partilha dos riscos entre setor privado e público.

CONCLUSÃO:

O Programa de Reestruturação e Qualificação da Rede Hospitalar e de Atenção Especializada da Cidade de São Paulo - Avança Saúde II, apresentado pelo Município de São Paulo - SP, sob a carta-consulta 60999, tem como objetivo contribuir para a melhora das condições de saúde da população da capital paulista, por meio da ampliação do acesso, da qualidade dos serviços ofertados, da garantia de segurança do paciente e da melhoria do desempenho dos processos da rede hospitalar municipal. O Programa implementará soluções voltadas para as políticas de saúde destinadas: (i) ao processo de reestruturação hospitalar de unidades de saúde no Município de São Paulo; (ii) à criação de um sistema de informação adequado, moderno e que possibilite a troca de informações gerenciais; (iii) à qualificação e modernização da rede física hospitalar existente e (iv) à qualificação da equipe da Secretaria Municipal da Saúde para o enfrentamento dos desafios que estão em constante transformação. O órgão executor do projeto será a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que terá como função a coordenação do Programa, com a responsabilidade de assegurar seus recursos, realizar articulações necessárias, acompanhar e supervisionar sua execução. A SMS estabelecerá uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que servirá como órgão de ligação entre a SMS, o Banco e demais participantes.

Conclui-se que o Programa apresentado pelo Município de São Paulo atende aos requisitos necessários para seu encaminhamento à Cofiex. Recomenda-se o aprimoramento posterior, com a participação dos agentes financiadores do projeto, das definições e cálculos dos indicadores e da avaliação dos riscos e ações mitigadoras para a sua implementação, para que fique mais bem demonstrado como se dará o acompanhamento de sua execução, resultados esperados e posterior avaliação, assim como o conhecimento do proponente sobre as políticas de aquisição e de salvaguardas do agente financeiro externo e sua capacidade de prevenir e/ou reduzir impactos supervenientes à execução do programa.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da Cofiex, com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Caroline Leite Nascimento
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica apresentada.
À apreciação do Coordenador-Geral.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.